



**ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР
ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І
«ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

ID здобувача / Student ID							
3	8	2	1	1	0	4	17

Прізвище / Surname									
М	И	Т	Р	О	П	О	Л	І	Т
С	Б	К	А						

Варіант / Variant 61

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО
ІСПИТУ**

КРОК 3

спеціальність

«НЕВРОЛОГІЯ»

1. Пацієнт віком 43 роки на 4-й день від початку інфекції скаржиться на підвищення температури тіла, головний біль, запаморочення, диспептичні розлади. Об'єктивно спостерігається: загальмованість, пригніченість, астенодепресивний стан. Ліквор кров'янистий. Який найімовірніший діагноз?

- A. —
- B. Герпетичний енцефаліт
- C. Туберкульозний менінгіт
- D. Грипозний енцефаліт
- E. Коровий енцефаліт

2. Чоловік віком 35 років з токсичним гепатитом в анамнезі скаржиться на підвищену дратівливість, збудливість, періодичні напади гніву, агресивності. Який соматоневрологічний синдром є провідним у цьому разі?

- A. Неврастенічний
- B. Гострої печінкової метаболічної енцефалопатії
- C. Іпохондричний
- D. Енцефаломієлопатії
- E. —

3. Пацієнт віком 40 років скаржиться на нападоподібний головний біль, який виникає вночі, нудоту, блювання, запаморочення, шум у вухах, світлочутливість. Симптоми Керніга, Брудзинського позитивні, але виражені нерізно. Прямий симптом Аргайлла Робертсона позитивний. Який найімовірніший діагноз?

- A. Туберкульозний менінгіт
- B. Менінгококовий менінгіт
- C. Герпетичний енцефаліт
- D. Сифілітичний менінгіт
- E. —

4. У чоловіка віком 28 років без втрати свідомості спостерігаються напади посмикування правої кисті, що поширюються на праву половину обличчя і тривають декілька хвилин. Після нападу відзначається нетривала слабкість руки. Вкажіть тип нападу.

- A. Кожевніківська епілепсія
- B. Генералізований тоніко-клонічний напад
- C. Джексоновська епілепсія
- D. Істерія
- E. Міоклонія

5. У пацієнта віком 54 роки під час неврологічного огляду виявлено: синдром Горнера. Які симптоми спостерігаються у пацієнта?

- A. Мідріаз, птоз, лагофталм
- B. Мідріаз, птоз, енофтальм
- C. Міоз, птоз, енофтальм
- D. Міоз, птоз, екзофтальм
- E. Птоз, міоз, диплопія

6. Чоловік віком 43 роки працює на підприємстві з виробництва гуми, скаржиться на підвищене емоційне виснаження, емоційну лабільність, які знижують працездатність, нюхова, тактильна, зорова види чутливостей знижені. Об'єктивно спостерігається: яскраво-червоний дермографізм, гіпергідроз долоней із потовиділенням краплями. Лабораторно: сеча має запах редьки. Отруєння якою речовиною спричинило появу цих симптомів у пацієнта?

- A. Свинцем
- B. Ртуттю
- C. Сірководнем
- D. Метилловим спиртом
- E. —

7. До лікаря-невролога звернулася пацієнтка віком 23 роки з порушенням роботи лівої половини обличчя, що виникла раптово вчора зранку. Під час огляду виявлено: гомолатеральні провисання брови і м'язів обличчя, згладження носогубної складки, нездатність повністю закрити око чи підняти кут рота. Лікар встановив діагноз: параліч Белла. Який з перерахованих препаратів необхідно призначити в перші 72 год для покращення прогнозу відновлення?

- ☒ А. Преднізолон
- В. Вітамін В₁₂ (ціанокобаламін)
- С. Ацикловір
- Д. Прозерин (неостигмін метилсульфат)
- Е. Диклофенак натрію

8. Укажіть препарат першої лінії для лікування судомного епілептичного статусу.

- А. Пропофол
- В. Карбамазепін
- С. Фенобарбітал
- ☒ Д. Діазепам
- Е. Тіопентал натрію

9. Жінка віком 24 роки без хронічних захворювань в анамнезі скаржиться на виражену чутливість до холоду, а також нападopodobне побіління пальців обох кистей з відчуттям їх оніміння. Інколи виникають відчуття поколювання та невірність рухів у дистальних відділах пальців кистей. Об'єктивно спостерігається: з боку ЧМН патології не виявлено. Чутливість не порушена. Глибокі рефлексі жваві, симетричні. Мозочкової та екстрапірамідної симптоматики не виявлено. Якому діагнозу відповідає описана клінічна картина?

- ☒ А. Синдрому Рейно
- В. Облітеруючому артеріосклерозу
- С. Еритромелалгії
- Д. Комплексному регіонарному больовому синдрому
- Е. Полінейропатії

10. У пацієнта віком 25 років спостерігається швидко прогресуюча двобічна слабкість проксимальних відділів ніг, відсутність колінних і ахілових рефлексів, парестезії в ногах. Під час обстеження не виявлено антитіла до ацетилхолінових рецепторів в сироватці крові. У спинномозковій рідині спостерігається білково-клітинна дисоціація. Який найімовірніший діагноз?

- ☒ А. Синдром Ламберта-Ітона
- ~~В. Міастенія гравіс~~
- С. Синдром Гійєна-Барре
- Д. Пухлина кінського хвоста
- Е. Пухлина спинного мозку

11. У пацієнта віком 34 роки невралгія 1-ї гілки трійчастого нерва праворуч. Який препарат є першою лінією терапії цього захворювання?

- А. Неостигмін
- В. Новокаїн
- С. Пентоксифілін
- ☒ Д. Карбамазепін
- Е. Німесулід

12. Пацієнт звернувся до приймального відділення, оскільки випадково випив алкоголь невідомого походження. Назвіть основні клінічні симптоми отруєння метиловим спиртом.

- А. Психомоторне збудження
- В. Зниження слуху
- С. Синкопальний стан
- ☒ Д. Зниження гостроти зору або сліпоту
- Е. Порушення нюху

13. Жінка віком 28 років більше 7-ми років хворіє на розсіяний склероз. Упродовж останніх 3-х днів стан погіршився: наросла слабкість у ногах, посилилася хиткість під час ходьби. У неврологічному статусі: горизонтальний ністагм, м'язова сила в ногах знижена до 3-х балів, високі сухожилкові рефлексі, клонуси стоп двобічно, симптом Бабінського (+) двобічно, черевні рефлексі не викликаються, хиткість у позі Ромберга, інтенційний тремор під час виконання координаторних проб. Ступінь інвалідизації за шкалою EDSS зріс на 1 бал. Укажіть метод лікування, показаний у цьому разі.

- ☒ А. Пульс-терапія кортикостероїдами
- В. Антигенспецифічна терапія
- С. Плазмаферез
- Д. Терапія моноклональними тілами
- Е. Пероральне введення кортикостероїдів

☒ 14. Чоловік віком 45 років скаржиться на опущення повік і двоїння в очах, які зникають до ранку. Лікар запідозрив, що у пацієнта міастенія. Який метод дослідження допоможе підтвердити діагноз?

☒ А. ЕНМР

В. Люмбальна пункція

С. КТ

Д. ЕЕГ

Е. МРТ

15. Лікар-інтерн вивчав роботу методу, який заснований на принципі детекції електромагнітних коливань окремих дипольних молекул води у мозку після збудження їх у магнітному полі 3 Тл. Укажіть цей метод.

☒ А. УЗД

В. Електроенцефалографія

С. КТ

Д. МРТ

Е. Ентропія

16. У військовослужбовця після поранення в ділянці зовнішньої поверхні правого колінного суглоба нижче голівки маломілкової кістки виникла слабкість у стопі. Висловлює скарги на утруднену ходу, неможливість стояти на правій п'яті. Об'єктивно спостерігається: права стопа звисає, її розгинання неможливе, під час ходьби степаж праворуч. Виявлена гіпалгезія по латеральній поверхні гомілки і стопи з правого боку. Який нерв пошкоджено в пацієнта?

☒ А. *Nervus peroneus communis*

В. *Nervus cutaneus surae lateralis*

С. *Nervus peroneus superficialis*

Д. *Nervus peroneus profundus*

Е. *Nervus tibialis*

17. У дівчини віком 23 роки вже двічі спостерігалися генералізовані тоніко-клонічні напади, які були зафіксовані на ЕЕГ. Укажіть препарати першої лінії для лікування епілептичних нападів.

А. Діазепам, габапентин

В. Окскарбазепін, топірамат

С. Фенобарбітал, фенітоїн

☒ Д. Вальпроєва кислота, ламотриджин

Е. Карбамазепін, леветирацетам

18. Чоловік віком 36 років скаржиться на ниючий біль у лівому передпліччі та кисті, що посилюється під час фізичної роботи. У неврологічному статусі: м'язова гіпотрофія кисті ліворуч, слабкість згиначів,

особливо І, ІІ пальців, гіпостезія кисті на долонній поверхні. Установіть попередній діагноз.

А. Тунельна нейропатія ліктьового нерва

☒ В. Тунельна нейропатія серединного нерва

С. Тунельна нейропатія променевого нерва

Д. Вертеброгенний корінцевий синдром С5-С6 ліворуч

Е. Полінейропатія

19. У пацієнта спостерігається птоз, вимушене положення очного яблука (поворот вниз та до зовні), та розширення зіниці. Ця тріада симптомів характерна для повного ураження якого нерва?

А. Відвідного

☒ В. Окорухового

С. Трійчастого

Д. Блокового

Е. Лицевого

20. Пацієнту встановлено діагноз: розсіяний склероз, первинно-проградієнтний перебіг. Об'єктивно спостерігається: помірний тетрапарез, гіпестезія та гіпалгезія лівої верхньої кінцівки з дистальним превалюванням. За допомогою якої шкали можна оцінити ступінь інвалідизації та прогресування захворювання?

А. FOUR

В. BARTHEL

☒ С. EDSS

Д. NIHSS

Е. El Escorial

21. У чоловіка віком 28 років, який отримав травму — переломом ключиці, з'явився в'ялий атрофічний парез правої руки з порушенням усіх видів чутливості в ній. Який патологічний стан виник у пацієнта?

А. Полінейропатія

В. Шийно-грудний радикуліт

С. Синдром кубітального каналу

☒ Д. Правобічний плечовий плексит

Е. Цервікоторакалгія

22. У пацієнта віком 42 роки після підйому вантажу виник гострий біль

у попереку, що іррадіює по задній поверхні лівого стегна. За результатами неврологічного огляду виявлено: виражена болючість паравертебральних точок у поперековому відділі, напруження довгих м'язів спини, гіпалгезія по зовнішній поверхні лівої гомілки та стопи, м'язова слабкість в розгиначах пальців лівої ноги, зниження ахілового рефлексу ліворуч. Який патогенетичний механізм захворювання?

- А. Подразнення синуввертебрального нерва
- ☒ В. Гостра компресія корінців L5-S1
- С. Гостра радикулоішемія L5
- Д. Гостра компресія кінського хвоста
- Е. Гостра компресія артерії Депрож-Готтерона

23. Пацієнт віком 25 років звернувся зі скаргами на головний більстискальний характеру в скроневій і потиличній зоні, 2-3 рази на тиждень протягом 4-5 місяців. Появу головного болю ні з чим не пов'язує, травм голови, спини не було. АТ — 125/80 мм рт. ст. Починалися напади головного болю легкої та середньої інтенсивності, був позитивний ефект від прийому анальгетиків. Останні 2 місяці інтенсивність і частота головного болю збільшилася, ефект від препаратів знизився. Зараз приймає комплекс анальгетиків з НПЗП. Який тип головного болю у пацієнта на момент звернення?

- А. Абузусний
- В. Напруження
- ☒ С. Кластерний
- Д. Невралгічний
- Е. Мігренозний

24. Під час обстеження, лікар-невролог діагностував у пацієнта порушення чутливості на обличчі праворуч за сегментарним типом у зонах Зельдера. Ураженням яких структур та на якому рівні можна пояснити виявлені зміни?

- А. Гассероного вузла
- В. Термінального ядра трійчастого нерва на рівні моста
- С. Корінця трійчастого нерва в мосто-мозочковому куті
- Д. II та III гілки трійчастого нерва на обличчі
- ☒ Е. Ядра спинномозкового тракту трійчастого нерва на рівні довгастого мозку

25. Ураження якої ділянки головного мозку призводить до апраксії одягання?

- ☒ А. Недомінантної тім'яної
- В. Домінантної тім'яної
- С. Недомінантної лобної
- Д. Домінантної лобної
- Е. Домінантної скроневої

26. Під час неврологічного огляду чоловіка віком 25 років виявлено: вазомоторні розлади, розлади зору (геміанопсія, набряк дисків зорових нервів), птоз, розбіжну косоокість та депресивний синдром. На рентгенограмі черепа — утворення в ділянці турецького сідла. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- ☒ А. Синдром вегетативної дисфункції
- В. Аденома гіпофіза
- С. Інсульт у стовбурі мозку
- Д. Мігрень без аури
- Е. Розсіяний склероз

27. Чоловік віком 34 роки скаржиться на судоми в ногах, болючі спазми м'язів кистей, посіпування повік. Із анамнезу відомо, що у пацієнта діагностовано: гіпопаратиреоз. Під час неврологічного огляду спостерігається: позитивні симптоми Хвостека та Труссо. Чим зумовлені неврологічні порушення в пацієнта?

- ☒ А. Порушеннями кальцієво-фосфорного обміну
- В. Порушеннями вуглеводного обміну
- С. Дефіцитом факторів протромбінового комплексу
- Д. Дефіцитом вітамінів групи В
- Е. Розладами водно-електролітного балансу

28. У якій структурі головного мозку розташований центр горизонтально-координованої дії окорухових м'язів?

- A. Середній мозок
- ☒ B. Міст
- C. Мозочок
- D. Внутрішня капсула
- E. Покришка

29. У чоловіка віком 70 років після переохолодження виник сильний біль у лівій половині голови в ділянці лоба та лівого ока. Через 3 дні на тлі підвищення температури тіла до $37,6^{\circ}\text{C}$ з'явилися пухирцеві висипання на чолі ліворуч та на лівій верхній повіці. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Неврит трійчастого нерва
- B. Невралгія трійчастого нерва
- C. Холодова алергія
- ☒ D. Герпетичний гангліоніт вузла трійчастого нерва
- E. Дерматит

30. Укажіть епілептичний напад, який характеризується продромальною фазою, втратою свідомості, тонічною фазою, клонічною фазою, у постіктальному періоді — летаргією, головним болем та слабкістю.

- A. Генералізований атонічний
- B. Фокальний міоклонічний
- C. Абсанси
- ☒ D. Генералізований тоніко-клонічний
- E. Фокальний тоніко-клонічний

31. Пацієнт віком 70 років, правша, скаржиться на раптову появу слабкості у правих кінцівках та нетримання сечі, що почалося приблизно 10 год тому. Із анамнезу відомо, що хворіє на цукровий діабет 2-го типу протягом останніх 20-ти років і на артеріальну гіпертензію протягом останніх 28 років. Об'єктивно спостерігається: м'язова сила у правій верхній кінцівці — 4 бали, сила в правій нижній кінцівці — 1 бал, з правого боку — симптом Бабінського. Чутливість знижена по всій правій стопі та гомілці. Візуальні поля без недоліків. Який найімовірніший діагноз?

A. Інсульт у правій середній мозковій артерії

☒ B. Інсульт у передній мозковій артерії

C. Інсульт у задній мозковій артерії

D. Лакунарний інсульт

E. Оклюзія внутрішньої каротидної артерії

32. Чоловік віком 78 років скаржиться на виражений тремор верхніх кінцівок. Із анамнезу відомо, що раніше зловживав алкоголем, тремор з'явився 15-17 років тому, відомо, що у матері пацієнта також спостерігався тремор. Під час неврологічного огляду виявлено: акційно-постуральний тремор з елементами інтенції, частотою близько 8 Гц, двобічний, проте більше виражений у правій руці. Тести на брадикінезію негативні, позитивний симптом Марінеску-Родовича. Спостерігаються ознаки сенситивної атаксії, проте п'яtkово-колінну пробу виконує без зауважень. Який найімовірніший діагноз?

A. Інтоксикаційна енцефалопатія ?

B. Хвороба Вільсона

C. Хвороба Паркінсона ?

D. Ессенціальний тремор

E. Ідіопатична дегенерація мозочка

33. Чоловік віком 45 років скаржиться на двоїння предметів перед очима, мимовільні рухи та порушення координації в кінцівках ліворуч. У неврологічному статусі праворуч визначаються: птоз, мідріаз, розбіжна косоокість, ліворуч — геміатаксія та гіперкінез. Який синдром розвинувся у пацієнта?

A. Клодта

B. Вебера

C. Фуа

☒ D. Бендикта

E. Монакова

34. У пацієнта після введення неостигміну метилсульфату зменшується стомлюваність м'язів, підвищується фізичне навантаження. Який патологічний стан, найімовірніше, спостерігається у пацієнта?

- A. Аміотрофія
- B. Нейропатія
- C. Міопатія
- D. Міотонія
- E. Міастенія**

35. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на постійний головний біль, більше виражений зранку, після сну, що супроводжується нудотою, відчуттям нечіткості зору, головокружінням. Із анамнезу відомо, що головний біль виник через добу після отриманої черепно-мозкової травми внаслідок швидкого гальмування автівки, в якій вона перебувала. Об'єктивно спостерігається: АТ — 110/60 мм рт. ст., пульс — 50/хв, у неврологічному статусі визначається дрібний горизонтальний ністагм, нестійкість під час проби Ромберга, рефлекс на кінцівках різко знижені. На очному дні межі диску зорового нерва нечіткі, вени звивисті, розширені. Який синдром спостерігається у пацієнтки?

- A. Панічний розлад
- B. Підвищення внутрішньочерепного тиску**
- C. Прогресивної вегетативної недостатності
- D. Зниження внутрішньочерепного тиску
- E. Психовегетативний

36. У пацієнта віком 46 років спостерігається проникне поранення хребта на рівні верхнього краю Th11 хребця. Які сегменти спинного мозку можуть бути уражені в цьому разі?

- A. L4-L5 —
- B. Th12-L1
- C. S1-S2 —
- D. L2-L3
- E. Th10-Th11 —

37. Жінку віком 57 років впродовж 2-3 місяців турбує пекучий біль у стопах. З анамнезу відомо, що 7 років хворіє на цукровий діабет 2-го типу, цукрознижувальну терапію приймає нерегулярно. У неврологічному статусі виявлено: схуднення м'язів гомілок, сухість та блідість шкіри, рефлекс на ногах торпідні, чутливість знижена за типом «шкарпе-

ток». Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Атеросклероз нижніх кінцівок
- B. Діабетична полінейропатія**
- C. Нейропатія сідничного нерва
- D. Нейропатія маломілкових нервів
- E. Ендартеріт нижніх кінцівок

38. Жінку віком 30 років шпиталізовано до неврологічного відділення зі скаргами на слабкість у ногах, відчуття оніміння стоп, хитку ходьбу. За результатами неврологічного обстеження виявлено: нижній парапарез зі зниженням больової та вібраційної чутливості дистально в ногах, збереженими функціями тазових органів, рефлексів з нижніх кінцівок симетрично підвищені, патологічних рефлексів не виявлено. Із анамнезу відомо, що протягом 7-ми років хворіє на B₁₂-дефіцитну анемію. Який патологічний стан можна запідозрити у пацієнтки?

- A. Фунікулярний мієлоз**
- B. Гостре порушення спинномозкового кровообігу
- C. Сирингомієлію
- D. Хворобу мотонейрона
- E. Сенсорну полінейропатію

39. Укажіть найчастішу причину нетравматичного субарахноїдального крововиливу?

- A. Розрив менінгеальних артерій
- B. Амілоїдна ангіопатія
- C. Розрив артеріальної аневризми**
- D. Гемангіома
- E. Апоплексія гіпофізу

40. У пацієнта раптово виникла гомонімна правобічна геміанопсія без збереження центральних полів зору. Укажіть локалізацію ураження зорового шляху.

- A. Зоровий тракт ліворуч між хіазмою та латеральним колінчастим тілом**
- B. Сітківка лівого ока
- C. Зоровий нерв ліворуч до рівня хіазми —
- D. Зоровий тракт ліворуч між латеральним колінчастим тілом та корою
- E. Зорова кора ліворуч

41. У пацієнта з діагнозом: B_{12} -дефіцитна анемія — з'явилося відчуття повзання «мурах», слабкість у ногах, похитування при ходьбі. Під час неврологічного огляду спостерігається: помірна атаксія, нижній дистальний парапарез із порушенням чутливості. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

- ☒ А. Поліневропатія
- ☐ В. Дисциркуляторна енцефалопатія
- ☐ С. Токсична енцефалопатія
- ☐ D. Невроз
- ☐ E. Мієлопатія

42. Жінка віком 26 років скаржиться на інтенсивний пульсуючий біль у правій половині голови, який іррадіює в око, посилюється від голосних звуків, світла. Подібні напади відбуваються вже протягом 6-ти років. Перед нападом відчуває посилену чутливість до запахів. Установіть попередній діагноз.

- ☐ А. Кластерний головний біль
- ☐ В. Синдром шийних симпатичних вузлів
- ☒ С. Мігрень із аурую
- ☐ D. Епізодичний головний біль напруги
- ☐ E. Шийна мігрень

43. Жінка віком 35 років скаржиться на м'язову слабкість кистей та стоп. В анамнезі поліомієліт. Об'єктивно спостерігається: м'язи проксимальних відділів кінцівок атрофовані. Для ураження яких структур спинного мозку характерні ці клінічні прояви?

- ☐ А. Заднього рогу
- ☐ В. —
- ☐ С. Заднього корінця
- ☐ D. Переднього корінця
- ☐ E. Переднього рогу

44. Чоловік віком 40 років доставлений бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги з підозрою на гостре порушення мозкового кровообігу. За результатами комп'ютерної томографії виявлено крововилив у ділянці правої половини моста мозку. Який судинний басейн уражено у пацієнта?

- ☐ А. Хребетна артерія праворуч
- ☐ В. Середня мозкова артерія праворуч
- ☒ С. Основна артерія
- ☐ D. Задня сполучна артерія
- ☐ E. Задня мозкова артерія праворуч

45. Укажіть, як змінюється тонус м'язів пацієнта у позі Верніке-Манна?

- ☐ А. М'язова гіпотонія в паретичних кінцівках
- ☒ В. Спастичне підвищення м'язового тону у паретичних кінцівках — згиначах руки та розгиначах ноги
- ☐ С. Підвищення пластичного тону у м'язах шиї
- ☐ D. Спастичне підвищення м'язового тону у згиначах руки та ноги з протилежного від вогнища боку
- ☐ E. Підвищення м'язового тону у всіх кінцівках за пластичним типом

46. Пацієнтка віком 58 років звернулася до лікаря з приводу труднощів під час ходьби. Із анамнезу відомо, що останні кілька тижнів вона відчувала двостороннє оніміння стоп та поколювання в них, 2 місяці тому їй діагностували прогресуючу лімфому Ходжкіна, зараз вона проходить курс хіміотерапії, що містить блеоміцин, доксорубіцин і вінкристин. Хворіє на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію. Неврологічне обстеження — двостороння слабкість під час тильного згинання стоп і втрата больової та температурної чутливості великих пальців обох ніг. Колінні рефлекс збережені, ахілів рефлекс відсутній з обох кінцівок. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Компресія кінського хвоста
- ☐ В. Оклюзія передньої мозкової артерії
- ☒ С. Периферична нейропатія на тлі хіміотерапії
- ☐ D. Діабетична нейропатія
- ☐ E. Компресія спинного мозку на грудному рівні

47. У пацієнта віком 36 років під час неврологічного огляду спостерігається: гіперакузія з порушенням чутливості на передніх 2/3 язика, прозопарез праворуч. Який нерв ураже-

ний?

- A. Язикоглотковий
- B. Під'язиковий
- ☒ C. Лицевий
- D. Трійчастий
- E. Блукаючий

48. Під час неврологічного огляду чоловіка віком 65 років спостерігається: скутість під час рухів, гіпомімія, ходить човгаючи, наявна поза «згиначів», тихе монотонне мовлення, ритмічний тремор пальців кистей. Яке захворювання виникло у пацієнта?

- A. Енцефаломієліт
- ☒ B. Хвороба Паркінсона
- C. Летаргічний енцефаліт
- D. Розсіяний склероз
- E. Хорея Гентінгтона

49. Хлопець віком 18 років скаржиться на різкий головний біль, запаморочення, нудоту, блювоту, підвищення температури тіла до 39°C , біль у м'язах, загальну слабкість, особливо в руках. Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому повернувся з практики в селі, де вживав у їжу сире козяче молоко. Об'єктивно спостерігається: мляві парези проксимальних відділів руки, менінгеальні симптоми. Установіть попередній діагноз пацієнту.

- A. Інфекційний поліневрит
- B. Геморагічний інсульт
- C. Епідемічний енцефаліт
- D. Серозний менінгіт
- ☒ E. Кліщовий енцефаліт

50. Дівчина віком 23 роки скаржиться на різкий головний біль, підвищення температури тіла до 39°C , блювання. Об'єктивно спостерігається: загальмована, позитивні менінгеальні симптоми, ознаки ураження III та IV пар черепних нервів. Результати аналізу ліквору: мутний, тиск підвищений, цитоз — 20000 (переважно нейтрофіли), білок — 3 г/л. Яке захворювання виникло у пацієнтки?

- A. Пухлина головного мозку
- ☒ B. Менінгококковий менінгіт
- C. Субарахноїдальний крововилив
- D. Туберкульозний менінгіт
- E. Енцефаліт

51. Пацієнт віком 38 років звернувся по медичну допомогу з приводу епізодів втрати свідомості, які виникають здебільшого під час фізичного навантаження, тривають до 2-3 хв, після чого швидко приходить до тями. Під час обстеження у пацієнта виявлено АВ блокаду II ступеня. Яка найбільш імовірна причина втрати свідомості у пацієнта?

- A. Панічний розлад
- B. Сопор
- C. Транзиторні ішемічні атаки
- D. Епілептичні напади
- ☒ E. Синкопальні стани

52. Чоловік віком 67 років раптово відчув слабкість у правих кінцівках, порушилося мовлення. Об'єктивно спостерігається: моторна афазія, правобічний геміпарез з об'ємом рухів до 4 балів. АТ — 130/80 мм рт. ст., ЧСС — 70/хв. Через 2 год неврологічна симптоматика регресувала. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- ☒ A. Транзиторна ішемічна атака
- B. Інфаркт мозку в лівій півкулі головного мозку
- C. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- D. Інфаркт мозку в правій півкулі головного мозку
- E. Субарахноїдальний крововилив

53. У пацієнта, інфікованого ВІЛ, за останній день виникло 4 генералізованих судомних напади. Після останнього нападу був шпиталізований. Об'єктивно спостерігається: ригідність потиличних м'язів, моторна афазія та правобічний геміпарез. Виконано МРТ головного мозку з контрастним підсиленням, яке виявило кільцеподібні вогнища з перифокальним набряком, які накопичують контраст у вигляді тонкої облямівки. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні результати?

- A. Гострого розсіяного енцефаліту
- B. Токсоплазмозу головного мозку**
- C. Аутоімунного енцефаліту на тлі СНІДу
- D. Множинного метастатичного ураження головного мозку
- E. Демієлінізуючого ураження головного мозку

54. У пацієнта із діагнозом: розсіяний склероз — з'явилася диплопія після одного року ремісії. Яке дослідження необхідно провести для вирішення питання про доцільність призначення пульс-терапії метилпреднізолоном?

- A. ЕНМГ
- B. МРТ головного мозку з в/в контрастуванням**
- C. Аналіз крові на антитіла до ацетилхолінових рецепторів
- D. Огляд очного дна
- E. МРТ головного мозку

55. Чоловік віком 43 роки звернувся зі скаргами на біль у зоні іннервації сідничного нерва, сильний біль у ділянці сечового міхура, що посилюється під час кашлю та чхання. Для синдрому ураження якого відділу спинного мозку характерні такі клінічні прояви?

- A. Кінського хвоста**
- B. Епіконуса
- C. Поперекового відділу спинного мозку
- D. —
- E. Мозкового конуса

56. Жінка віком 30 років скаржиться на появу висипань у вигляді пухирців на тулубі з правого боку, які супроводжуються болем, підвищенням температури тіла, вираженою слабкістю на боці ураження. Для ураження яких анатомічних структур характерні ці клінічні прояви?

- A. Заднього рогу
- B. —
- C. Бічного стовпа спинного мозку
- D. Міжхребцевого ганглію**
- E. Заднього корінця

57. Одинадцятирічну дитину впродовж 3-х днів турбували нежить, кашель, біль у животі, підвищення тем-

ператури тіла до 38,5°C. До кінця третього дня катаральні явища зменшилися, температура тіла нормалізувалася. На четвертий день раптово виникла слабкість у правій нозі. У неврологічному статусі: відсутні активні рухи в нозі, болючість при пасивних рухах, гіпотонія, нервові стовбури болючі під час пальпації. Колінний та ахілів рефлексів праворуч відсутні. Із анамнезу відомо, що дитина не вакцинована згідно з календарем щеплень. Який патологічний стан виник у дитини?

- A. Поліомієліт, спінальна форма**
- B. Ботулізм
- C. Поліомієліт, понтинна форма
- D. Енцефаломієліт
- E. Кліщовий енцефаліт

58. Жінка віком 55 років після стресової ситуації близько 60 хв була дезорієнтована в часі та просторі, не могла пригадати, що стало приводом до сварки в родині, багаторазово повторює одні і ті самі питання. Лікар екстреної (швидкої) медичної допомоги виявив: свідомість збережена, АТ — 145/90 мм рт. ст., пульс — 100/хв, ЧД — 18/хв, глюкоза крові — 6,6 ммоль/л. За результатами ЕКГ виявлено: ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. В анамнезі: артеріальна гіпертензія. У неврологічному статусі спостерігається слабкість конвергенції з обох боків, позитивні рефлексів орального автоматизму, глибокі рефлексів поживавлені та симетричні, патологічних рефлексів не виявлено. Який найімовірніший діагноз?

- A. Істеричний напад
- B. Панічна атака
- C. Транзиторна глобальна амнезія**
- D. Ішемічний інсульт
- E. Гіпертонічний криз

59. Пацієнта із підозрою на субарахноїдальний крововилив шпиталізовано до стаціонару. Яке обстеження необхідно провести для термінової нейровізуалізації?

- A. МРТ головного мозку
- B. Люмбальну пункцію з цитологічним аналізом ліквору
- C. МСКТ головного мозку з в/в контрастуванням
- D. МСКТ головного мозку**
- E. Рентгенографію черепа

60. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на біль, оніміння, поколювання, печіння в нижніх кінцівках. З анамнезу відомо, що хворіє на автоімунний гастрит. Який провідний соматоневрологічний синдром спостерігається в цьому разі?

- A. Неврастенічний
- B. —
- C. Мієлопатичний**
- D. Компресійний
- E. Корінцевий

III 61. Протягом останніх двох днів чоловік помітив у себе опущення правої повіки, двоїння при погляді прямо, вгору, вниз та досередини. Під час огляду спостерігається: розбіжна косокосість OD, анізокорія D>S, права зіниця не реагує на світло, порушення акомодатції. Ураження якого черепно-мозкового нерва можна запідозрити?

- A. Трійчастого
- B. Окорухового**
- C. Відвідного
- D. Зорового
- E. Блокового

62. Пацієнтка віком 42 роки звернулася до лікаря-невролога зі скаргами на асиметрію обличчя, сухість ока, підвищену чутливість до звуків, порушення смаку на 2/3 язика, сухість в роті та парез мимічних м'язів ліворуч. Укажіть місце ураження лицевого нерва в пацієнта.

- A. Після відходження великого каменистого нерва —
- B. До відходження великого каменистого нерва**
- C. До відходження стремінцевого нерва —
- D. При виході з шило-соскоподібного отвору
- E. До відходження барабанної струни —

63. Жінка віком 70 років після пробудження виявила слабкість правих кінцівок, розлад мовлення, порушення чутливості у правій половині тіла. Артеріальний тиск — 100/60 мм рт. ст. У неврологічному статусі визначаються правобічний центральний геміпарез та гемігіпалгезія, моторна афазія. Який попередній діагноз?

- A. Субарахноїдальний крововилив
- B. Ішемічний інсульт**
- C. Пухлина головного мозку
- D. Геморагічний інсульт
- E. Енцефаліт

64. Під час неврологічного огляду у пацієнта спостерігається порушення поверхневої чутливості. Укажіть, у якій анатомічній структурі розташовані тіла III нейронів.

- A. Таламусі**
- B. Спинномозковому ганглію
- C. Тонкому та клиноподібному ядрі довгастого мозку
- D. Передніх рогах спинного мозку
- E. Задніх рогах спинного мозку

65. Пацієнту віком 50 років діагностовано синдром Гійєна-Барре з порушенням функції дихання. Який руховий синдром розвинувся у пацієнта?

- A. Центральний тетрапарез
- B. Периферичний тетрапарез**
- C. Комбінований тетрапарез
- D. Комбінований нижній парапарез
- E. Комбінований верхній парапарез

66. У пацієнта після травми плеча з'явилася слабкість м'язів дистального відділу лівої руки, гіпотрофія м'язів та біль лівої кисті. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Шийна радикулопатія
- B. Нижній плечовий плексит Дежеріна-Клюмпке**
- C. Сирингомієлія
- D. Бічний аміотрофічний склероз
- E. Синдром «плече-кисть»

67. Чоловік віком 27 років скаржиться на біль у передпліччі, що посилюється при пронації та згинанні ліктьового суглоба, втрату чутливості у всій долоні, слабкість згинан-

ня великого пальця та встановлення його в одній площині з другим пальцем кисті. Позитивний тест Тінеля над круглим пронатором. Ураження якого нерва спостерігається у пацієнта?

- А. Ліктьового
- ☒ В. Серединного
- С. Ліктьового та променевого
- Д. Променевого
- Е. Плечового сплетення

68. Пацієнт віком 30 років скаржиться на напад судом, який трапився вперше. Який метод дослідження доцільно використати в цьому разі?

- А. УЗД
- В. Люмбальну пункцію
- ☒ С. Електроенцефалографію
- Д. КТ
- Е. МРТ

69. Які симптоми характерні для пацієнта з ураженням нижньої тім'яної часточки домінантної півкулі головного мозку?

- А. Головний біль, запаморочення
- В. Сенсомоторна афазія, дисфагія, геміпарез, гемігіпестезія, підвищення сухожилково-періостальних рефлексів
- ☒ С. Центральний геміпарез, пальцева агнозія, порушення право-лівого орієнтування, дисграфія, дискалькулія, аутоскопичний феномен
- Д. Однобічне просторове ігнорування
- Е. Соматотопагнозія, геміанестезія, атаксія

70. У пацієнта локалізація вогнища ураження — у ділянці нижньої лобової звивини домінантної півкулі. Який патологічний стан виникне у пацієнта?

- А. Амнестична афазія
- ☒ В. Моторна афазія
- С. Скандоване мовлення
- Д. Семантична афазія
- Е. Сенсорна афазія

71. Пацієнт не може назвати добре знайомі предмети (іменники). Для якого типу афазії це характерно?

- ☒ А. Амнестичної
- В. Сенсорної
- С. Апраксії
- Д. Моторної
- Е. Семантичної

72. Пацієнту віком 62 роки діагностовано: гостре порушення мозкового кровообігу у вертебробазиллярному басейні. Під час неврологічного огляду виявлено: ністагм при погляді праворуч, інтенційний тремор під час виконання пальце-носової та п'ятково-колінної проб правими кінцівками й адіадохокінез у правій руці. Яка з нижченаведених структур була уражена?

- А. Ліва половина моста
- В. Права половина моста
- С. Ліва півкуля мозочка
- Д. Ліва половина довгастого мозку
- ☒ Е. Права півкуля мозочка

73. Чоловік віком 30 років скаржиться на раптові епізоди запаморочення, що супроводжуються нудотою та блюванням, тривають 30-60 с та провокуються зміною положення тіла. Лікар запідозрив захворювання: доброякісне пароксизмальне позиційне головокружіння. Який діагностичний метод дозволить підтвердити діагноз?

- А. Аудіометрія
- В. МРТ шийного відділу хребта
- ☒ С. Маневр Дікса-Холлпайка
- Д. Дуплекс брахіоцефальних судин
- Е. Маневр Еплі

74. Чоловіка віком 33 роки після ДТП шпиталізовано до відділення невідкладної допомоги без свідомості. Об'єктивно спостерігається: анізокорія, свідомість на рівні коми І, тонус м'язів симетрично знижений, патологічних рефлексів не виявлено. За результатами КТ головного мозку виявлено гіперінтенсивне вогнище на конвекситальній поверхні мозку у формі лінзи. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- А. Субарахноїдальний крововилив
- В. Субдуральна гематома
- С. Варіант норми
- ☒ Д. Епідуральна гематома
- Е. Внутрішньомозковий крововилив

75. Чоловік віком 37 років скаржиться на двоїння предметів перед очима, асиметрію мімічної мускулатури ліворуч. У неврологічному статусі ліворуч визначається: периферичний прозомонопарез, параліч латерального м'яза ока, праворуч — геміплегія зі збереженням функції мімічних м'язів. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- А. Раймона-Сестана
- В. Фовілля
- С. Бріссо-Сікара
- Д. Гасперіні
- ☒ Е. Мійяра-Гублера

76. Передній та латеральний спіноталамічні тракти проводять імпульси від рецепторів шкіри, які сприймають тактильну, температурну та больову чутливості всіх частин тіла, окрім обличчя. Укажіть 3 нейрони цих трактів.

- А. I нейрон — зубчате ядро, II нейрон — черв'як мозочка, III нейрон — нижні червоні ядра
- В. I нейрон — покривка стовбуру мозку, II нейрон — черв'як мозочка, III нейрон — нижні холмики *corpora quadrigemina*
- С. I нейрон — моторна кора, II нейрон — середній мозок, III нейрон — ядро трійчастого нерва
- Д. I нейрон — спінальний ганглії, II нейрон — *nucleus cuneatus/gracilis* (довгастий мозок), III нейрон — таламус (вентральне постеролатеральне ядро)
- ☒ Е. I нейрон — спінальний ганглії, II нейрон — задній ріг спинного мозку (*substantia gelatinosa*), III нейрон — таламус (вентральне постеролатеральне ядро)

77. У чоловіка віком 36 років упродовж пів року спостерігалися погіршення емоційного стану, поступове порушення пам'яті. За результатами досліджень виявлено: метаболічний ацидоз, збільшення та ущіль-

нення печінки, збільшення селезінки. У неврологічному статусі: помірна деменція, екстрапірамідний тремор рук, легка олігобрадикінезія, симптом Марі (+), Нойка-Ганева (+) двобічно, ахейрокінез. Проведене МРТ-обстеження головного мозку виявило атрофію подушки та блідої кулі. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Постенцефалітний паркінсонізм
- В. Хвороба Паркінсона
- ☒ С. Гепатолентикулярна дегенерація
- Д. Акінетичний мутизм
- Е. Гіперпаратиреоз

78. Жінка віком 60 років звернулася до лікаря-невролога зі скаргами на виражений біль у поперековому відділі хребта. Із анамнезу відомо: екстирпація матки через рак тіла матки 4 роки тому. Встановлено діагноз: гостра радикулопатія L5 корінця з вираженим больовим та м'язово-тонічним синдромами. Легкий лівобічний нижній переважно дистальний периферичний монопарез. Лівобічна гіпестезія за дерматомом L5. Які дообстеження та з якою метою необхідно виконати цій пацієнтці?

- А. МР-спектроскопію
- ☒ В. МРТ попереково-крижового відділу хребта через наявність у пацієнтки «червоних прапорців»: вік, онкоанамнез
- С. КТ попереково-крижового відділу хребта через наявність у пацієнтки «червоних прапорців»: вік, онкоанамнез
- Д. УЗД органів малого тазу
- Е. Загальний аналіз крові та онкологічні біомаркери через наявність у пацієнтки «червоних прапорців»: вік, онкоанамнез

79. Пацієнт віком 30 років отримав черепно-мозкову травму внаслідок ДТП. Стан свідомості — кома. Яку шкалу найчастіше використовують для оцінки рівня ком?

- ☒ А. Глазго
- ☐ В. Мауо
- ☐ С. Розена
- ☐ D. Хачинського
- ☐ Е. —

80. У пацієнта, що звернувся по допомогу з приводу вираженого тремору, під час неврологічного огляду було виявлено дисметрію та інтенцію при проведенні пальце-молоточкової проби. Укажіть, у якій структурі мозку може локалізуватись осередок.

- ☒ А. Потилична частка
- ☐ В. Мозочок
- ☐ С. Базальні ганглії
- ☐ D. Міст
- ☐ Е. Лобна частка

81. У пацієнта віком 43 роки, що зловживає алкоголем, після сну виникло відчуття незграбності в правій руці. Під час неврологічного огляду виявлено слабкість під час тильного розгинання кисті. Який нерв, найімовірніше, уражено?

- ☐ А. Ліктьовий
- ☐ В. М'язово-шкірний
- ☐ С. Серединний
- ☒ D. Променевий
- ☐ Е. Підлопатковий

82. Пацієнт віком 36 років звернувся зі скаргами на постійні мимовільні рухи в кінцівках, тулубі, посмикування обличчя, висовування язика, ці рухи хаотичні, він не може їх контролювати, вони зникають тільки під час сну. Порушення мовлення, яке стало тихим та нечітким. Порушення пам'яті, роздратованість. В анамнезі встановлено: батько мав подібні симптоми та помер у віці 54 роки. У неврологічному статусі пацієнта: виражені мимовільні рухи у всіх частинах тіла, проте більше виражені у верхньому плечовому поясі, дизартрія. СПР та чутливість у межах норми. МРТ головного мозку — зменшення розмірів голівок хвостатих ядер двобічно, дифузна атрофія речовини головного мозку. Який найбільш імовірний діагноз?

- ☐ А. Хвороба Вільсона
- ☒ В. Хвороба Гентінгтона
- ☐ С. Хвороба Паркінсона
- ☐ D. Хвороба Галлервордена-Шпатца
- ☐ Е. Хорея Сиденхема

83. У чоловіка віком 62 роки під час неврологічного обстеження спостерігається: гіпертермія, розбіжна координованість, вегетативні розлади («сальне обличчя», загальний гіпергідроз). Пацієнт сонний, під час спроби його розбудити скаржиться на двоїння в очах. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- ☐ А. Гострий енцефаломієліт
- ☐ В. Арахноїдит
- ☐ С. Паненцефаліт
- ☒ D. Епідемічний енцефаліт
- ☐ Е. Розсіяний склероз

84. Пацієнт віком 40 років скаржиться на відчуття «внутрішнього перенапруження», неспокою, тривожності. Дружина помітила неспровоковані зміни в поведінці чоловіка, вказує на підвищений фон настрою, невмотивовану ейфоричність, виражені емоційні реакції, ажитованість. Результатом якої дії на відповідну структуру головного мозку є ця симптоматика?

- ☐ А. Ірритації ретикулярної формації
- ☒ В. Ірритації лімбічної системи
- ☐ С. Пригнічення лімбічної системи
- ☐ D. Пригнічення лобної частки
- ☐ Е. Ірритації гіпоталамічної ділянки

85. Чоловік віком 36 років скаржиться на слабкість у кінцівках, головний біль, нудоту, було дворазове блювання. Об'єктивно спостерігається: зіниці вузькі, фотореакція зіниць млява, загальний гіпергідроз, підвищене слиновиділення. У сироватці крові виявлено зниження активності холінестерази. Із анамнезу відомо, що протягом дня зважував хімічні реактиви без респіратора. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Отруєння бензином
- В. Харчова токсикоінфекція
- С. Отруєння ртуттю
- ☒ Д. Гостра інтоксикація фосфорорганічними сполуками
- Е. Отруєння миш'яковими пестицидами

86. Під час вивчення фізіологічних процесів у нервовій клітині встановлено, що нейронами, розташованими в *substantia nigra*, виділяється біологічно активна речовина з гальмівним ефектом. Який це, ймовірно, нейромедіатор?

- А. Ацетилхолін
- В. Гліцин
- С. Дофамін
- Д. Глутамат
- Е. ГАМК

87. Яка з нижченаведених пухлин нервової системи може розвиватися зі структур периферичних нервів?

- А. Менінгіома
- В. Астроцитома
- ☒ С. Шванома
- Д. Гліома
- Е. Меланома

88. Пацієнта віком 72 роки шпиталізовано до лікарні в стані свідомості — кома. Об'єктивно спостерігається: температура тіла фебрильна, ригідність м'язів потилиці — 3 см, симптом Керніга — 15° двобічно. Незадовго до шпиталізації спостерігався генералізований тоніко-клонічний білатеральний напад. Протягом останнього тижня був сонливий, скаржився на кашель. Зранку відчув головний біль та нечіткість зору. Протягом дня його стан поступово погіршувався, були блювання, розлади свідомості до коми. Який метод обстеження допоможе встановити діагноз?

- А. Фундоскопія
- ☒ В. Люмбальна пункція
- С. Краніографія
- Д. Електроенцефалографія
- Е. Доплерографія судин головного мозку

89. Чоловік віком 34 роки скаржиться на двоїння предметів перед очима,

порушення координації в кінцівках з лівого боку. У неврологічному статусі праворуч визначаються птоз, мідріаз, розбіжна косоокість, ліворуч — геміатаксія, інтенційний тремор. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- А. Фуа
- ☒ В. Клодта
- С. Монакова
- Д. Вебера
- Е. Бенедикта

90. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на різке зниження настрою, депресію, фіксований на своїх почуттях, зазначає щодо появи періодичних відчуттів печіння та свербіжів шкіри. В анамнезі: довгий час зловживає алкоголем та хворіє на цироз печінки. Який соматоневрологічний синдром провідний у цьому разі?

- А. —
- ☒ В. Печінкової метаболічної енцефалопатії
- С. Енцефаломієлопатії
- Д. Іпохондричний
- Е. Неврастенічний

91. Чоловік віком 76 років на тлі помірного цефалгічного синдрому помітив появу розладів мовлення, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: гіпертонічна хвороба, ІХС, інфаркт міокарда, пароксизмальна форма фібриляції передсердь. У неврологічному статусі: часткова сенсомоторна афазія, центральний геміпарез та гемігіпалгезія з парезом м'язів за центральним типом праворуч. Який метод лікування показаний пацієнту?

- А. Антикоагулянтна терапія
- В. Подвійна антиагрегантна терапія
- С. Декомпресійна краніотомія
- Д. Вентрикуло-перитонеальне шунтування
- ☒ Е. Тромболітична терапія

92. Пацієнта віком 50 років шпиталізовано з правобічною слабкістю, затерпінням у кінцівках та порушенням мовлення. В анамнезі: гіпертонічна хвороба, гіперліпідемія, цукровий діабет 2-го типу. Не зловживає алкоголем, курить протягом

45-ти років. Об'єктивно спостерігається: правобічна геміплегія, правобічна анестезія, гомонімна геміанопсія та афазія. За результатами КТ головного мозку виявлено: великого розміру гемісферний інфаркт. Через неможливість точної верифікації часу початку захворювання тромболізис проведено не було. Через 48 год стан пацієнта почав погіршуватися. Температура тіла — 38,3°C, АТ — 154/86 мм рт. ст., пульс — 64/хв. Який наступний крок ведення пацієнта?

- A. ЕЕГ
- B. Люмбальна пункція
- C. Повторити КТ головного мозку
- D. В/в ввести маніт
- E. МРТ головного мозку

93. Чоловіка віком 42 років шпиталізовано до приймального відділення лікарні зі скаргами на блювання, сльозотечу, діарею, часте сечовипускання та болісні спазми в животі. Об'єктивно спостерігається: зіниці симетричні, звужені, погано реагують на світло. ЧСС — 84/хв, дихання поверхневе та часте, АТ — 120/90 мм рт. ст., профузний піт. Із анамнезу відомо, що чоловік хворіє на міастенію. Зі слів дружини, стан швидко погіршився під час обробки городу від жуків. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Отруєння ФОС
- B. ТІА
- C. Холінергічний криз
- D. ГРВІ
- E. Міастенічний криз

94. Унаслідок ураження якої анатомічної структури виникає амавроз?

- A. Зорового нерва
- B. Нюхової цибулини
- C. Зорового шляху
- D. Нюхового шляху
- E. Бічного колінчастого тіла

95. Пацієнт віком 57 років скаржиться на раптову слабкість м'язів однієї половини обличчя, сльозотеча із того самого боку та зміни смаку. Встановлено попередній діагноз: ідіопатичний параліч лицевого нерва. Яка ознака допоможе відрізнити

центральне ураження лицевого нерва від периферичного?

- A. Порушення смаку* буде при периферичному паралічі, а при центральному — ні
- B. Сльозотеча буде при периферичному паралічі, а при центральному — ні
- C. Функції м'язів лоба будуть збережені при центральному паралічі, при периферичному — ні
- D. Порушення смаку буде при центральному паралічі, а при периферичному — ні
- E. Функції м'язів лоба будуть збережені при периферичному паралічі, а при центральному — ні

96. За допомогою якої класифікації розрізняють 5 патогенетичних варіантів ішемічного інсульту?

- A. TOAST
- B. ASPECTS
- C. NIHSS
- D. МОЗОК-ЧАС
- E. АНА/АSA

97. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на опущення правої повіки та двоїння в очах, які практично не турбують вранці, але посилюються протягом доби. Початок захворювання пов'язує з перенесеним грипом. Під час обстеження спостерігається правобічний птоз та розбіжна косоокість за рахунок правого ока. Інших розладів з боку черепно-мозкових нервів, розладів рухової сфери або чутливості не виявлено. За результатами імунологічного дослідження виявлено: наявність аутоантитіл до рецепторів ацетилхоліну (AchR-AB). Із якого препарату необхідно розпочати лікування пацієнтки?

- A. Піридостигміну
- B. Спіронолактону
- C. Метилпреднізолону
- D. Ритуксимабу
- E. Азатиоприну

98. Чоловіка віком 48 років шпиталізовано до відділення реанімації та інтенсивної терапії з порушенням свідомості. Під час огляду спостерігається: на звернене мовлення роз-

$$3 + 4 + 4 = 11$$

плющує очі, дезорієнтований, відповідь не адекватна запитанню, на больові подразники посмикує кінцівки. Скільки балів за шкалою ком Глазго у цього пацієнта?

- A. 7-8
- B. 10-11**
- C. 5-6
- D. 13-14
- E. 4-5

99. У пацієнта запідозрено закрити черепно-мозкову травму. Укажіть основну ознаку струсу головного мозку.

- A. Геміпарез
- B. Парез погляду вгору
- C. Утворення каротидно-кавернозної нориці
- D. Субарахноїдальний крововилив**
- E. Ретроградна амнезія**

100. Для псевдобульбарного синдрому, як і для бульбарного синдрому, характерна класична тріада: дизартрія, дисфонія та дисфагія. Які ще з нижченаведених симптомів характерні для псевдобульбарного синдрому?

- A. Мимовільний плач і сміх**
- B. Атаксія та тремор
- C. Дистонія
- D. Дисметрія
- E. Адіадохокінез

101. Жінку віком 56 років доставлено до приймального відділення лікарні. Відомо, що сьогодні зранку в неї розвинувся генералізований клоніко-тонічний білатеральний судомний напад. Подібний напад був 6 місяців тому. Із анамнезу відомо, що хворіє на артеріальну гіпертензію, 3 роки тому перенесла ЗЧМТ, забій головного мозку. Під час огляду: температура тіла — 36,8°C, АТ — 165/100 мм рт. ст., наявний менінгеальний синдром, елементи моторної афазії, правобічна рефлексорно-пірамідна недостатність. У спинномозковій рідині змін не виявлено, на КТ головного мозку діагностовано лікворну кісту лівої гемісфери розміром 33x17x21 мм, кортико-атрофічні зміни після-травматичного генезу. Призначення якої групи препаратів першої лінії

показано пацієнтці?

- A. Антигіпертензивних засобів
- B. Габапентинового ряду
- C. Препарати вальпроєвої кислоти**
- D. Транквілізаторів бензодіазепінового ряду
- E. Прегабалінів

102. Який симптом може виникнути у пацієнта з ураженням задньої мозкової артерії ліворуч?

- A. Афазія Верніке
- B. Лівобічна гомонімна геміанопсія
- C. Правобічний гемінеглект
- D. Правобічна гомонімна геміанопсія**
- E. Лівобічний гемінеглект

103. У хлопця віком 27 років упродовж 4-х років поступово виникла слабкість у ногах, змінилася ходьба, розвинувся гіперлордоз поперекового відділу хребта. Об'єктивно спостерігається: центральный нижній легкий парепарез із високим тонусом, деформація стоп. Чутливих та вегетативних порушень не виявлено. Зі слів пацієнта, подібне захворювання є у батька. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бічний аміотрофічний склероз
- B. Спінальна форма розсіяного склерозу
- C. Гострий РЕМ, форма дисемінованого мієліту
- D. Спадкова спастична пареплегія Штрюмпеля**
- E. Спадкова полінейропатія Шарко-Мари-Тута

104. Пацієнт віком 35 років скаржиться на незграбність рук та біль від ліктьового суглоба до кисті протягом 3-х місяців. Із анамнезу відомо, що працює діловодом у приватній компанії та не є фізично активним, не курить і не вживає алкоголю. За результатами неврологічного обстеження виявлено зниження чутливості 4-го та 5-го пальців правої руки зі зниженням м'язової сили до 4 балів порівняно з лівою рукою. Яка найімовірніша локалізація патологічного процесу?

- А. Ліктьова ямка
- В. Середня частина передпліччя
- С. Зап'ястя
- Д. Плечовий суглоб
- Е. Пахва

105. У чому полягає клінічна відмінність судинної форми паркінсонізму від хвороби Паркінсона?

- А. Симетричний початок із вертикальним офтальмопарезом
- В. Симетричний початок із переважним порушенням функції ходьби
- С. Симетричний початок із переважанням тремору в нижніх кінцівках
- Д. Асиметричний початок із переважним порушенням функції ходьби
- Е. Асиметричний початок із зоровими галюцинаціями

106. За допомогою якої шкали проводиться оцінка тяжкості стану пацієнта в гострому періоді ішемічного інсульту?

- А. NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)
- В. Індекса Бартел
- С. Гамільтона
- Д. Ешворта
- Е. MMSE (Mini-Mental State Examination)

107. У чоловіка віком 67 років, який довгий час хворіє на артеріальну гіпертензію та фібриляцію передсердь, раптово виникло двоїння при погляді ліворуч, асиметрія обличчя та слабкість у правих кінцівках. Об'єктивно спостерігається: збіжна косоокість за рахунок OS, лівобічний прозопарез та центральний правобічний геміпарез. Укажіть назву альтернуючого синдрому.

- А. Фовілля
- В. Мійяра-Гюблера
- С. Бріссо-Секара
- Д. Бенедикта
- Е. Вебера

108. Пацієнт віком 37 років протягом 5-ти років хворіє на розсіяний склероз. За останній тиждень помітив появу похитування при ходьбі, інтенційного тремору та промахування під час виконання пальце-носової та колінно-п'яткової проб, скандова-

ного мовлення. Яка структура нервової системи вражена?

- А. Верхні ніжки мозочка
- В. Хробак і півкулі мозочка
- С. Міст
- Д. Червоне ядро
- Е. Передні відділи лобної частки

109. Чоловік віком 36 років скаржиться на двоїння предметів перед очима, оніміння обличчя ліворуч, асиметрію мимічної мускулатури ліворуч, зниження слуху на ліве вухо, слабкість та оніміння в кінцівках з лівого боку. У неврологічному статусі ліворуч визначаються: гіпестезія обличчя, збіжна косоокість, лагофталм, ліворуч — геміпарез, гемігіпестезія. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- А. Бріссо-Сікара
- В. Мійяра-Гюблера
- С. Гасперіні
- Д. Фовілля
- Е. Раймона-Сестана

110. Пацієнт віком 43 роки внаслідок ДТП отримав травму голови. Об'єктивно спостерігається: ринолікворея, кровотеча з носа, вух, екхімози в параорбітальних ділянках. Яке ушкодження, найімовірніше, виникло в пацієнта?

- А. Перелом основи черепа
- В. —
- С. Субдуральна гематома
- Д. Перелом склепіння черепа
- Е. Забій головного мозку

111. Який із нижченаведених лікарських засобів є препаратом першої лінії для лікування хронічної мігрені?

- А. Цинаризин
- В. Карбамазепін
- С. Левотирацетам
- Д. Прегабалін
- Е. Топірамат

112. У жінки віком 38 років поступово розвивалися атактичні та пірамідні порушення, проведено МРТ головного мозку. Отримані результати показали множинні ділянки округлої та овальної форми, переважно з

чіткими контурами без вираженого перифокального набряку, розмірами від 4х4 мм до 18х23 мм у підкіркових відділах обох гемісфер мозку, перивентрикулярно, у променистих вінцях у мозолистому тілі, лівій ніжці мозку та у лівій гемісфері мозочка. Для якого патологічного стану характерні зміни, що були виявлені на МРТ головного мозку?

- А. Хвороби Бінсвагнера
- В. Розсіяного склерозу
- С. Множинного метастатичного ураження головного мозку
- Д. Фунікулярного мієлозу
- Е. Хвороби Лайма

113. У пацієнта віком 37 років після сну раптово розвинулася слабкість у лівій стопі, труднощі під час ходьби. З анамнезу відомо, що напередодні ввечері вживав алкоголь. Під час неврологічного огляду виявлено: парез тильного згинання стопи, гіпестезія по зовнішньому краю гомілки та на тильній поверхні стопи. Який найімовірніший діагноз?

- А. Радикулопатія корінця S1
- В. Демієлінізуюче ураження грудного відділу хребта
- С. Невропатія малогомілкового нерва
- Д. Менінгіома конвекситальної поверхні правої півкулі мозку
- Е. Невропатія великогомілкового нерва

114. Пацієнта віком 42 роки шпиталізовано до лікарні після генералізованого тоніко-клонічного білатерального судомного нападу, що виник уперше. Об'єктивно спостерігається: дезорієнтований, на запитання відповідає із затримкою. У неврологічному статусі: чутливі тригемінальні точки під час пальпації, симптом Керніга 40° двобічно, ригідність потиличних м'язів 2 см. Після проведення МСКТ головного мозку: ASPECTS-10, rs-ASPECTS-10, даних про вогнищеве ураження головного мозку не виявлено. Який наступний метод обстеження рекомендований для цього пацієнта?

- А. Доплерографія інтракраніальних судин головного мозку
- В. МРТ головного мозку з в/в контрастуванням
- С. Люмбальна пункція
- Д. Електроенцефалографія
- Е. Доплерографія екстракраніальних судин головного мозку

115. У чоловіка віком 43 роки виявлено правобічний прозопарез зі слюзотечею. Із анамнезу відомо, що місяць тому пацієнт звернувся до лікаря-дерматолога з приводу еритематозних кільцеподібних плям на шкірі стегна. Установіть попередній діагноз пацієнту.

- А. Ішемічний інсульт в судинах ВББ
- В. Невринома мосто-мозочкового кула
- С. Параліч Белла
- Д. Понтинна форма поліомієліту
- Е. Нейробореліоз

116. Чоловік віком 65 років з постінфарктним кардіосклерозом, порушенням серцевого ритму та аденомою простати раптово відчув слабкість у ногах та перестав утримувати сечу. Об'єктивно спостерігається: АТ — 155/90 мм рт. ст., пульс — 90/хв, ЧД — 18/хв. Температура тіла нормальна. У неврологічному статусі спостерігається центральный спастичний парепарез, порушення функції тазових органів за типом імперативних позивів до сечовипускання. Якому діагнозу відповідає описана клінічна картина?

- А. Полінейропатія —
- В. Гострий мієліт —
- С. Спінальний інсульт
- Д. Церебральний інсульт —
- Е. Облітеруючий артеріосклероз судин нижніх кінцівок —

117. Пацієнтка віком 60 років звернулася до сімейного лікаря через чотири тижні після перенесеного гострого ішемічного інсульту. В анамнезі: тривала гіпертонічна хвороба, цукровий діабет 2-го типу, ішемічна хвороба серця, застійна серцева недостатність і фібриляція передсердь. Під час огляду на прохання підняти ліву руку, вона піднімає праву. При

проведенні тесту годинника пацієнтка ставить цифри тільки з правого боку. Яка з часток головного мозку, найімовірніше, уражена в пацієнтки?

- A. Ліва скронева
- B. Ліва фронтальна
- C. Права потилична
- D. Права фронтальна
- ☒ E. Права тім'яна

118. У пацієнта після ДТП було діагностовано гостру епідуральну гематому зліва. Під час неврологічного огляду виявлено: пацієнт не розуміє зверненого до нього мовлення, але здатний самостійно чітко та зрозуміло говорити. Яка із нижченаведених структур головного мозку, найімовірніше, уражена?

- A. Гіпофіз
- B. Центр Брока
- C. Гіпоталамус
- ☒ D. Центр Верніке
- E. Ретикулярна формація

119. У жінки віком 40 років, яка звернулася до лікаря-невролога, діагностовано хворобу Штрюмпеля. Укажіть провідний синдром ураження при цьому захворюванні.

- A. Повного поперекового ураження спинного мозку —
- B. Половинного ураження спинного мозку —
- C. Переднього рогу, пірамідального тракту —
- D. —
- ☒ E. Кортикоспінального тракту

120. У пацієнта з пухлиною спинного мозку на нижньо-шийному рівні діагностовано втрату больової та температурної чутливості за провідниковим типом з рівня Th2 праворуч та глибокої і тактильної чутливості ліворуч з рівня C8. Який руховий розлад виникне у пацієнта?

C8
ліво
периферич рука
ліва
нога ліва рука

- A. Периферичний парез правої руки, центральний парез лівої ноги
- B. Периферичний парез правої руки, центральний парез правої ноги
- C. Периферичний парез лівої руки, центральний парез лівої ноги
- D. Периферичний парез лівої руки, центральний парез правої ноги
- E. Периферичний парез рук, центральний парез ніг

121. Лікар-інтерн вивчав роботу методу обстеження для реєстрації біопотенціалів м'язів у спокої та під час скорочення. Як називається такий метод?

- A. МРТ
- B. Ентропія
- ☒ C. Електроміографія
- D. Електроенцефалографія
- E. КТ

122. Чоловік віком 40 років скаржиться на біль за вухом, послаблення смакової чутливості, слабкість м'язів правої половини обличчя. Вказані скарги з'явилися раптово після перенесеної вірусної інфекції. Укажіть найімовірніший діагноз.

- A. Діабетична нейропатія
- B. Невралгія трійчастого нерва
- C. —
- D. Параліч Белла
- E. Симптом Рамзі-Ганта

123. Пацієнт віком 34 роки захворів гостро з появи таких симптомів: на фоні психомоторного збудження розвинувся генералізований тоніко-клонічний білатеральний судомний напад. Із анамнезу відомо, що вживав алкогольні напої. Об'єктивно спостерігається: ажитований, некритичний, дещо агресивний, ригідність потиличних м'язів — 5 см, симптом Керніга — 45° двобічно. Періодична диплопія. Рухових та чутливих порушень не виявлено. Під час спинномозкової пункції ліквор витікає під тиском, колір кров'янистий, мікроскопічно — свіжі еритроцити. Який найімовірніший діагноз?

- А. Геморагічний менінгоенцефаліт —
- ☒ В. Субарахноїдальний крововилив
- С. Гострий гнійний менінгіт —
- Д. Паренхіматозний крововилив —
- Е. Гостра алкогольна енцефалопатія —

124. Які діагностичні шкали допоможуть лікарю оцінити наявність у пацієнта порушення абстрактного мислення (концептуалізації)?

- А. MMSE, MoCA
- В. CIBIS, MMSE, MoCA
- С. MoCA, FAB
- Д. MMSE, FAB, MoCA
- Е. Mini-Cog, MoCA

125. Чоловік віком 37 років скаржиться на інтенсивний головний біль, що виник раптово, супроводжується нудотою, багаторазовим блюванням. Об'єктивно спостерігається: АТ — 210/120 мм рт. ст., болючість тригемінальних та окципітальних точок під час пальпації, ригідність м'язів потилиці 4 см, позитивний симптом Керніга. Який метод обстеження показаний для верифікації діагнозу в цьому разі?

- А. ЕЕГ
- В. Люмбальна пункція
- С. УЗД вен голови та шиї
- Д. Краніографія
- ☒ Е. КТ головного мозку

126. Чоловік віком 45 років скаржиться на напади болю в корені язика під час вживання холодної та гарячої їжі. Тривалість болю — до 10 хв. Біль супроводжується сухістю в роті, а після нападу виділяється багато слини. Об'єктивно спостерігається: триггерні ділянки в зоні кореня язика. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Гангліоніт шийних симпатичних нервів
- В. Невралгія трійчастого нерва
- С. Гангліоніт крилопіднебінного нерва
- Д. Невралгія відієвого нерва
- ☒ Е. Невралгія язикоглоткового нерва

127. Жінка віком 58 років, яка хворіє на артеріальну гіпертензію, раптово під час психоемоційного напружен-

ня втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, гіперемія обличчя, пульс — 100/хв, напружений, АТ — 230/110 мм рт. ст. Опущений правий кут рота, дихання шумне, права щока парусить. Підняті праві кінцівки падають «як батюги», м'язовий тонус у них та рефлекс знижені, на лівих кінцівках збережені, позитивний симптом Бабінського праворуч. Який попередній діагноз?

- А. Інфаркт мозку
- В. Менінгіт
- ☒ С. Крововилив у ліву півкулю мозку
- Д. Субарахноїдальний крововилив
- Е. Гіпертонічний криз

128. Пацієнт віком 58 років має виражену тривожність через наявність повторюваних епізодів запаморочення, пов'язаних із поворотами голови, переважно праворуч, чи зміною положення, особливо під час підйому з ліжка після нічного сну. Своє захворювання пов'язує з перенесеною коронавірусною інфекцією. Під час проведення проби Дікса-Холлпайка виникає ністагм із латентністю 20 секунд та з ротаційним і вертикальним компонентом у напрямку правого вуха під час швидкої фази. Візуалізація голови, лабораторні дослідження та оцінка слуху відхилені від норми не виявили. Який найімовірніший діагноз?

- А. Вестибулярний неврит —
- В. Панічний розлад —
- ☒ С. Доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення
- Д. Хвороба Мен'єра —
- Е. Ортостатична гіпотензія —

129. До неврологічного відділення звернувся пацієнт зі скаргами на раптову появу двоїння в очах, що посилюється під час спроби відвести погляд ліворуч. Під час огляду виявлена збіжна косоокість ліворуч. Який черепний нерв та який окоруховий м'яз, що ним іннервується, зазнали ураження?

А. Лівий окоруховий нерв, внутрішній прямий м'яз

В. Лівий відвідний нерв, зовнішній прямий м'яз

С. Лівий окоруховий нерв, зовнішній прямий м'яз

Д. Правий відвідний нерв, зовнішній прямий м'яз

Е. Лівий відвідний нерв, внутрішній прямий м'яз

130. Чоловік віком 68 років скаржиться на порушення мовлення та слабкість у кінцівках праворуч, що виникли раптово 3 год тому. У неврологічному статусі визначаються: моторна афазія легкого ступеня, помірно виражений дисоційований правобічний геміпарез (брахіофасціальний тип). За даними комп'ютерної томографії головного мозку виявлено гіподенсивний осередок у кортикально-субкортикальних структурах лобової частки ліворуч. Які зміни біоелектричної активності головного мозку за даними електроенцефалографічного дослідження є найбільш очікуваними у цьому разі?

А. Генералізоване уповільнення ритмів

В. Фокальні повільні хвилі

С. Фокальні гострі хвилі

Д. Фокальні спайки

Е. Фокальні комплекси «гостра хвиля — повільна хвиля»

131. Під час огляду чоловіка віком 30 років лікар-невролог спостерігає відсутність адекватної реакції пацієнта на зовнішні подразники, у тому числі й на слова. Також у пацієнта виявлено такі симптоми: анартрія, параліч, свідомість повністю збережена, інколи при зверненні матері кліпає очима. Який стан розвинувся в пацієнта?

А. Акінетичний мутизм

В. —

С. Вегетативний стан

Д. Апатичний синдром

Е. Синдром «замкненої людини»

132. Яка анатомічна структура є покрівлею середнього мозку?

А. Мозочок

В. Сітчасте утворення

С. Огорожа

Д. Ніжки мозку

Е. Чотиригорбкове тіло

133. Чоловік віком 43 роки після травмування шийного відділу хребта звернувся до лікаря-невролога. Під час обстеження діагностовано синдром Броун-Секара. Укажіть провідну локалізацію ураження.

А. Ураження епіконуса

В. Повне поперекове ураження спинного мозку

С. Половинне ураження поперечника спинного мозку

Д. Ураження мозкового конуса

Е. —

134. Пацієнт віком 48 років хворіє на генералізовану форму міастенії 6 років, із приводу чого приймає піридостигмін та преднізолон. Упродовж останніх трьох днів стан пацієнта погіршився, слабкість наростала до вечора, з'явилися труднощі з ковтанням і диханням. У зв'язку з погіршенням стану та підозрою на міастенічний криз пацієнта шпиталізовано до відділення інтенсивної терапії. Яку невідкладну допомогу необхідно надати пацієнту?

А. Дексаметазон внутрішньовенно

В. Епінефрин внутрішньом'язово

С. Встановити назогастральний зонд

Д. Інтубацію трахеї

Е. Неостигмін внутрішньом'язово

135. У пацієнта після видалення пухлини спинного мозку через ураження шийного відділу виник синдром Горнера, що класично характеризується одностороннім птозом, міозом та снофтальмом. Які ще прояви можуть виникати в структурі цього ураження?

А. Парез акомодациї

В. Ринорея

С. Ангідроз половини обличчя

Д. Ністагм

Е. Диплопія при погляді вниз

136. Який лікарський засіб є препаратом вибору у лікуванні людей у віці до 45 років з первинно прогресуючим

суючим типом перебігу розсіяного склерозу?

- А. Терифлуномід
- В. Глатирамеру ацетат
- С. Диметилфумарат
- Д. β -інтерферони
- Е. Анти-CD 20 антитіла

137. Пацієнтка віком 25 років звернулася до лікаря-невролога зі скаргами на двоїння предметів перед очима, яке виникло гостро 3 дні тому. Напередодні відзначала тривалий стрес на роботі. Інших причин вказати не може. У неврологічному статусі: збіжна косоокість за рахунок OS, диплопія при погляді ліворуч. Іншої симптоматики не виявлено. Сестра матері пацієнтки хворіє на розсіяний склероз. На МРТ дослідженні головного мозку у T2-режимі виявлено два активних вогнища паравентрикулярної та одне активне вогнище юстакортикальної локалізації. Чи можливо в цьому клінічному випадку встановити заключний діагноз?

- А. Так, діагноз РС підтверджений дисемінацією у просторі на МРТ
- В. Так, діагноз РС підтверджений клінічною симптоматикою, анамнестичними даними і дисемінацією у просторі та часі на МРТ
- С. Ні, діагноз РС потребує підтвердження дисемінацією у часі на МРТ (повторне обстеження через 6 місяців) та виявленням олігоклональних специфічних антитіл у лікворі
- Д. Ні, діагноз РС потребує підтвердження за допомогою дослідження ліквору на виявлення специфічних олігоклональних антитіл
- Е. Так, діагноз РС підтверджений дисемінацією у просторі та дисемінацією у часі на МРТ

138. Пацієнтка віком 30 років звернулася зі скаргами на слабкість м'язів кінцівок, попірхування під час ковтання рідини. Об'єктивно спостерігається: незначна збіжна косоокість за рахунок правого ока, помірний птоз праворуч, зниження м'язової сили в проксимальних групах м'язів кінцівок до 3 балів. Порушення дихання відсутні. Розладів чутливості не виявлено. Із якого методу обсте-

ження рекомендовано розпочати обстеження?

- А. Стимуляційна електронейроміографія
- В. Антитіла до м'язово-специфічної кіннази (MuSK) в сироватці крові
- С. Тиреоїдна панель
- Д. Візуалізація тимуса
- Е. Антитіла до ацетилхолінових рецепторів (АХР) у сироватці крові

139. Породілля віком 35 років скаржиться на інтенсивний головний біль, початок якого вона пов'язує з пологами. Пологи відбувалися шляхом кесаревого розтину, під час яких була використана спінальна анестезія. Головний біль виникає у вертикальному положенні, посилюється під час тривалого перебування на ногах, у той же час біль зникає під час сну і практично не турбує, коли пацієнтка лежить без подушки. Який синдром спостерігається у породіллі?

- А. Післяпологової депресії
- В. Лікворної гіпотензії
- С. Менінгеальний
- Д. Підвищення внутрішньочерепного тиску
- Е. Загальномозковий

140. Чоловік віком 55 років із встановленим діагнозом: міастенія, очна форма анти-МСК позитивна — захворів на позагоспітальну пневмонію. Призначено антибіотик — ципрофлоксацин. Раптово у пацієнта розвинулася слабкість м'язів, утруднене дихання, пітливість, тахікардія, дисфагія, гіперсаливація. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Респіраторний дистрес-синдром
- В. Менінгоенцефаліт
- С. Міастенічний криз
- Д. Синдром Гійєна-Барре
- Е. Синдром Ландрі

141. Жінка віком 39 років звернулася до лікаря-невролога зі скаргами на слабкість м'язів обличчя з лівого боку, порушення смаку та надмірно голосний звук у лівому вусі. Патологічної сльозотечі не відзначає. Ураження якої з нижченаведених частин

лицевого нерва характерне для цієї симптоматики?

- А. Між ядром лицевого нерва та колінчастим ганглієм
- ☒ В. Між колінчастим ганглієм та стремінцевим нервом
- С. Ядра лівого лицевого нерва
- Д. Між стремінцевим нервом та барабанною струною
- Е. Між барабанною струною та шиლოსкоподібним отвором

142. Пацієнт віком 65 років скаржиться на часті падіння. Із анамнезу відомо, що протягом 2-х місяців втрачає рівновагу переважно при нахилах ліворуч та відчуває, що його «ліва половина тіла стала неконтрольованою». Він також скаржиться на періодичний головний біль та нудоту протягом 3-х місяців. В анамнезі: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2-го типу та інфаркт міокарда 10 років тому. Він заперечує вживання тютюну, алкоголю та наркотиків. Приймає метформін, ацетилсаліцилову кислоту та еналаприл. Вітальні функції в межах норми. У позі Ромберга хитається ліворуч навіть з відкритими очима. Коли його просять зробити кілька кроків, він іде обережно і хитається вліво. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хвороба Гентінгтона—
- В. Вестибулопатія —
- С. Гідроцефалія —
- Д. Шванома VIII пари черепно-мозкового нерва зліва —
- ☒ Е. Пухлина мозочка

143. У пацієнтки віком 59 років раптово виникла слабкість у правих кінцівках, вона перестала розуміти звернене мовлення. Об'єктивно спостерігається: АТ — 200/95 мм рт. ст., пульс — 95/хв, глікемія крові — 10,5 ммоль/л. Після обстеження виявлено появу гіподенсивних ділянок лівої тім'яної частки 28x17x5 мм та 12x10x10 мм з ознаками геморагічної трансформації. Який найімовірніший діагноз?

А. Лакунарні інфаркти лівої тім'яної частки

В. Ішемічний атеротромботичний інсульт у басейні лівої середньої мозкової артерії

С. Гострий мозковий інсульт у басейні лівої середньої мозкової артерії за ішемічним типом

Д. Ішемічний кардіоемболічний інсульт у басейні лівої середньої мозкової артерії

Е. Повторний (другий) ішемічний інсульт у басейні лівої середньої мозкової артерії

144. Ураження якого нерва спричинить справжнє нетримання сечі?

- А. Клубово-пахвинного —
- В. Додаткового затульного —
- С. Затульного —
- Д. Статено-стегнового —
- ☒ Е. Соромітного

145. Чоловік віком 36 років, який працює будівельником, після отриманої травми плеча скаржиться на обмеження активних рухів у плечовому суглобі, неможливість підняти руку до горизонтального рівня та зігнути руку в ліктьовому суглобі. Об'єктивно спостерігається: відсутність біцепс рефлексу, карпорадіального рефлексу, болючість під час пальпації у надключичній ямці, гіпестезія по зовнішній поверхні правого плеча. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- ☒ А. Брахіоплексит Дюшена-Ерба
- В. Тендініт ротаторної манжети плеча
- С. Компресійна мононевропатія ліктьового нерва
- Д. Мультифокальна моторна полінейропатія
- Е. Синдром замороженого плеча

146. Чоловік віком 72 роки скаржиться на загальну слабкість, труднощі під час виконання щоденних справ, забудькуватість. Зі слів доньки, що проживає разом із ним, за останній рік батько «сильно змінився», зокрема перестав користуватися побутовою технікою, почав забувати те, що чув кілька годин чи днів тому, став повільним і потребує значно біль-

ше часу, щоб поїсти чи одягнутися. Також донька помітила, що батько часто розказує, що бачить вдома ко-та, хоча у них вдома лише маленький собака. Під час неврологічного огляду виявлено симетричне підвищення тону-су м'язів у руках і ногах, незначний адіадохокінез, похитування в позі Ромберга. Патологічні рефле-кси відсутні. Згідно з даними Мон-реальського когнітивного тесту па-цієнт набрав 22 бали, найбільші тру-дності під час оцінювання були при малюванні годинника. Яке захворю-вання, найімовірніше, розвинулося у пацієнта?

- А. Судинна деменцію
- В. Деменція з тільцями Леві
- С. Фронтотемпоральна деменція
- Д. Деменція при нормотензивній гід-роцефалії –
- Е. Деменція при хворобі Альцгейме-ра

147. Після падіння з висоти на лі-ве плече у чоловіка виникла м'я-зова слабкість у лівій кисті. Об'є-ктивно спостерігається: ліва кисть звисає, розгинання кисті та пальців різко утруднене, неможливо відве-сти великий палець, гіпестезія в зоні анатомічної «табакерки». Ураження якої структури периферичного від-ділу нервової системи можна запідоз-рити у пацієнта?

- А. Серединного нерва (*n. medianus*)
- В. М'язово-шкірного нерва (*n. mus- culocutaneus*)
- С. Ліктьового нерва
- Д. Променевого нерва (*n. radialis*)
- Е. Плечового сплетення

148. У чоловіка віком 76 років в анамнезі гостре порушення мозково-

го кровообігу за ішемічним типом у середній мозковій артерії. Об'єктив-но спостерігається: згладженість но-согубної складки; опущеність кута рта та асиметрія при спробі посмі-хнутися. Ураження якого з нижчена-ведених провідних шляхів спричинив неврологічний дефіцит?

- А. Кірково-ядерного
- В. Текто-спінального
- С. Руброспінального
- Д. Бічного кірково-м'язового
- Е. Переднього кірково-м'язового

149. Восени 2023 року МОЗ України отримало як гуманітарну допомогу 87 флаконів дороговартісного пре-парату «Spingaza» (Нусінерсен). Для лікування якого захворювання вико-ристовується цей препарат?

- А. Прогресуючої м'язової дистрофії Дюшена
- В. Розсіяного склерозу –
- С. Спінальної аміотрофії II типу
- Д. Невральної аміотрофії Шарко-Ма-рі-Туте
- Е. Прогресуючої м'язової дистрофії Беккера

150. Пацієнт віком 43 роки з нирко-вою недостатністю скаржиться на біль у нижньогрудному та попере-ковому відділах хребта з іррадіацією в пахвинну ділянку, відчуття спраги. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, волога. Який соматоневроло-гічний синдром є провідним у цьому разі?

- А. Полінейропатичний
- В. Неврастенічний
- С. –
- Д. Реновісцеральний
- Е. Радикулярний –